

UNIVALI | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
Docentes: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib.
Disciplina: Trabalho Final de Graduação I.
Acadêmica: Luiza Dietrich da Silva | 7818840
Semestre: 2026.01 | 9º Período.

M2 - AC3 | ENSAIO CONCEITUAL

DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO FENÔMENO

O câncer configura-se hoje como um dos maiores desafios de saúde pública em escala global, sendo uma das primeiras causas de morte antes dos 70 anos em 112 países. No cenário brasileiro, a doença vem se consolidando como uma das principais causas de óbito, com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2026) estimando um aumento em novos casos anuais para o triênio de 2026 a 2028. Diante da alta complexidade da patologia, a literatura científica é enfática ao afirmar que o tratamento oncológico não pode ser restrito apenas à figura do médico oncologista; ele exige a atuação de uma equipe multidisciplinar para garantir uma abordagem holística e a qualidade de vida do paciente.

Entretanto, o impacto da doença transcende o paciente, estendendo-se a todo o âmbito familiar, que sofre mudanças radicais em sua dinâmica e enfrenta profundas angústias. Frequentemente, o sistema de saúde foca apenas na patologia em si, deixando de lado o acompanhante que, embora adoeça emocionalmente junto com o paciente, acaba invisibilizado nas estruturas de atendimento tradicionais. Muitos ambientes de tratamento ainda são percebidos como locais de vulnerabilidade emocional, insegurança e hostilidade, onde a frieza dos procedimentos técnicos reforça o estigma e o medo associados ao câncer.

A lacuna identificada reside, portanto, na carência de espaços físicos que materializam o suporte necessário a essa rede de apoio. Diante deste cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de um **Centro Oncológico Multidisciplinar Ambulatorial integrando um Centro de Apoio à Família**. O propósito é romper com a lógica do ambiente hostil e puramente funcional, transformando-o em um espaço de acolhimento humanizado. Ao invés de um local de isolamento, o projeto busca criar um ambiente, onde a arquitetura atue como uma ferramenta de suporte psicossocial, oferecendo segurança, dignidade e visibilidade tanto para o paciente quanto para seus familiares durante a jornada do tratamento.

JUSTIFICATIVA

- **Relevância Social**

A relevância social deste projeto está na necessidade de espaços de saúde mais humanizados para o atendimento oncológico, considerando que o câncer impacta não apenas o paciente, mas também toda a sua rede familiar. Nesse contexto, a arquitetura torna-se fundamental ao proporcionar ambientes que contribuam para o bem-estar físico, emocional e psicológico durante o tratamento.

O projeto do Centro Oncológico Multidisciplinar busca romper com a lógica hospitalar tradicional, propondo espaços acolhedores, confortáveis e integrados à natureza, capazes de reduzir sentimentos de ansiedade, medo e desgaste emocional. Além do atendimento médico, a proposta valoriza a experiência do paciente por meio da humanização dos ambientes, compreendendo a arquitetura como parte do processo de cuidado.

A integração de um Centro de Apoio à Família reforça a relevância social do projeto ao oferecer suporte aos familiares, frequentemente sobrecarregados pelo processo da doença. Dessa forma, o projeto propõe uma arquitetura voltada ao cuidado e acolhimento de pacientes e familiares, buscando tornar o ambiente hospitalar mais humano, sensível e inclusivo.

- **Relevância Técnico-Científica**

A relevância deste anteprojeto fundamenta-se na aplicação de princípios da arquitetura humanizada e terapêutica no desenvolvimento de um Centro Oncológico Multidisciplinar com apoio à família, compreendendo o espaço arquitetônico e o paisagismo como elementos ativos no processo de cuidado. A proposta busca elaborar ambientes que contribuam para o bem-estar físico, emocional e psicológico dos usuários, utilizando a arquitetura e a integração com a natureza como estratégias para qualificar a experiência do tratamento oncológico.

Os estudos de Roger Ulrich defendem que o ambiente físico influencia diretamente a recuperação e a redução do estresse dos pacientes. A partir do conceito de *Evidence-Based Design*, o autor destaca a importância da iluminação natural, das vistas para áreas verdes e dos jardins terapêuticos como elementos capazes de melhorar a experiência hospitalar e promover bem-estar durante o tratamento. No anteprojeto, esses princípios serão aplicados por meio da criação de áreas verdes e jardins terapêuticos, priorizando a relação visual do paciente com a natureza, especialmente a partir dos leitos e espaços de permanência.

A abordagem de Juhani Pallasmaa compreende a arquitetura como uma experiência sensorial e emocional, defendendo espaços que acolham os sentidos e promovam conforto e pertencimento. Seus estudos valorizam aspectos como luz, materialidade, escala humana e percepção espacial, entendendo que a arquitetura deve proporcionar ambientes mais sensíveis e acolhedores aos usuários. Dessa forma, o anteprojeto busca aplicar esses conceitos na criação de espaços que despertam sensações de acolhimento, tranquilidade e bem-estar para pacientes, familiares e profissionais da saúde.

João Filgueiras Lima (Lelé) defendia uma arquitetura hospitalar integrada ao conforto ambiental e à humanização dos espaços, utilizando ventilação natural, iluminação e relação com áreas externas como estratégias para melhorar a qualidade dos ambientes de saúde. Seus projetos demonstram a importância da arquitetura como instrumento de acolhimento, funcionalidade e qualidade de vida. No anteprojeto, esses princípios serão incorporados por meio de soluções que valorizem a ventilação e iluminação natural, além da integração entre ambientes internos e externos, contribuindo para espaços mais humanos e adequados ao tratamento oncológico.

Dessa forma, o anteprojeto busca integrar arquitetura e paisagismo na criação de ambientes internos e externos de permanência, convivência e acolhimento, fortalecendo a relação dos usuários com o espaço construído e contribuindo para uma experiência hospitalar mais humana, sensível e integrada à natureza.

- **Relevância Territorial**

No Brasil, o câncer representa um dos principais desafios da saúde pública, com estimativa de aproximadamente 781 mil novos casos por ano para o triênio 2026–2028 (INCA, 2026). As regiões Sul e Sudeste concentram cerca de 70% da incidência nacional da doença, evidenciando a necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura de atendimento oncológico no país (OBSERVATÓRIO DE ONCOLOGIA, 2024).

Na Região Sul, as projeções indicam cerca de 145.750 novos casos de câncer, com destaque para os tumores de mama, próstata e pulmão (INCA, 2026). Esse cenário demonstra a crescente demanda por equipamentos de saúde especializados capazes de oferecer não apenas tratamento técnico, mas também suporte físico, emocional e social aos pacientes e familiares durante o processo terapêutico.

Em escala regional, os municípios da Região da Foz do Rio Itajaí apresentam relevância estratégica devido ao intenso fluxo populacional e à dependência de deslocamentos intermunicipais para acesso ao tratamento oncológico especializado. A distância entre a residência e os centros de atendimento agrava o desgaste físico, emocional e financeiro dos pacientes e acompanhantes, especialmente durante tratamentos prolongados, como quimioterapia e radioterapia.

Dessa forma, a implantação de um Centro Oncológico Multidisciplinar na Região da Foz do Rio Itajaí justifica-se pela necessidade de descentralizar o atendimento especializado e fortalecer a rede de suporte entre paciente e família. Além da função assistencial, o anteprojeto propõe uma infraestrutura humanizada, integrada à arquitetura terapêutica e ao paisagismo, contribuindo para a qualidade de vida, acolhimento e bem-estar dos usuários durante o tratamento oncológico.

OBJETIVOS

- **Geral**

- Desenvolver um anteprojeto arquitetônico para um centro oncológico multidisciplinar ambulatorial que integre espaços de suporte, permanência e acolhimento para familiares.

- **Específicos**

- Estruturar um programa de necessidades voltado às demandas físico-espaciais e psicossociais de pacientes e familiares no contexto ambulatorial oncológico.
- Planejar fluxos e acessos que promovam integração da equipe multidisciplinar, eficiência funcional, privacidade e segurança dos usuários.

- Elaborar soluções arquitetônicas humanizadas que integrem iluminação natural e contato com a natureza como estratégias terapêuticas.
- Projetar espaços de acolhimento e suporte familiar que incentivem a convivência, apoio emocional e bem-estar durante o tratamento oncológico.

RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A literatura contemporânea define o câncer como um conjunto de patologias de alta complexidade que exige uma abordagem que ultrapasse o modelo médico isolado. Nesse contexto, a atuação de uma equipe multidisciplinar, torna-se indispensável para garantir um tratamento integral, considerando não apenas os sintomas físicos, mas também os impactos emocionais e psicossociais da doença (FARIAS, 2024). Além disso, a comunicação e a integração entre os profissionais e os pacientes contribuem diretamente para uma melhor compreensão do tratamento e maior qualidade no cuidado oferecido (TANAKA, 2020).

O diagnóstico oncológico também é compreendido como um processo de “adoecimento coletivo”, pois afeta profundamente a dinâmica familiar e impõe sobrecargas emocionais, físicas e socioeconômicas aos cuidadores (DE BORTOLI, 2020). Muitas vezes invisibilizada pelo sistema de saúde, a família assume um papel fundamental durante o tratamento, necessitando igualmente de acolhimento e suporte (CARVALHO, 2007). Nesse cenário, os espaços de apoio tornam-se essenciais para oferecer amparo emocional, convivência e suporte psicossocial aos acompanhantes, fortalecendo a rede de cuidado do paciente (DE BORTOLI, 2020).

Diante dessa complexidade, a arquitetura passa a exercer um papel ativo no processo terapêutico. O conceito de Arquitetura da Cura compreende o ambiente construído como um sistema capaz de influenciar diretamente o bem-estar e a recuperação dos usuários, por meio de estímulos sensoriais e da qualidade espacial. A partir do Design Baseado em Evidências, os estudos de Roger Ulrich demonstram que elementos como iluminação natural, vistas para áreas verdes e jardins terapêuticos contribuem significativamente para a redução do estresse, do tempo de internação e da necessidade de medicação analgésica (ULRICH, 1984). Dessa forma, a integração entre arquitetura e paisagismo torna-se uma estratégia terapêutica fundamental em ambientes oncológicos.

Essa abordagem humanizada é reforçada pelos princípios projetuais de João Filgueiras Lima (Lelé), que defendia uma arquitetura hospitalar integrada ao conforto ambiental, à funcionalidade e à relação com a natureza (GUERRA; MARQUES, 2015). Seus projetos utilizam soluções passivas de ventilação e iluminação natural para promover qualidade ambiental e bem-estar aos usuários, transformando os espaços hospitalares em ambientes mais acolhedores e menos institucionalizados.

A perspectiva, Peter Zumthor compreende a arquitetura como uma experiência sensorial e emocional, enfatizando a importância da “atmosfera” e da “presença” nos espaços (MERIN, 2013). Para o autor, elementos como luz, materialidade, sons e percepção espacial possuem capacidade de despertar sensações de acolhimento, tranquilidade e

pertencimento, contribuindo para a preservação da dignidade humana em momentos de fragilidade.

Dessa forma, o anteprojeto de um Centro Oncológico Multidisciplinar com apoio à família fundamenta-se na integração entre arquitetura, paisagismo e humanização, propondo ambientes terapêuticos que atendam às necessidades físicas, emocionais e psicossociais do binômio paciente-família. O objetivo é transformar o espaço de tratamento em uma infraestrutura de suporte à vida, promovendo acolhimento, qualidade ambiental e maior conexão entre os usuários e o ambiente construído.

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

A proposta fundamenta-se em três conceitos: **permanência, sensibilidade e acolhimento**, que estruturam o anteprojeto do Centro Oncológico Multidisciplinar ao compreender o espaço como parte fundamental da experiência do tratamento. A permanência está relacionada à criação de ambientes que proporcionem conforto e qualidade aos pacientes, familiares e profissionais durante longos períodos de espera, acompanhamento e cuidado, valorizando espaços de convivência, descanso e contemplação.

A sensibilidade manifesta-se na elaboração de ambientes que consideram os aspectos emocionais e psicológicos dos usuários, utilizando iluminação natural, integração com a natureza, materialidade e percepção espacial como elementos capazes de gerar bem-estar e reduzir o estresse causado pelo tratamento oncológico. Dessa forma, a arquitetura busca estabelecer uma relação mais humana e empática entre o usuário e o espaço construído.

O acolhimento, por sua vez, orienta a criação de uma atmosfera menos institucional e mais receptiva, reconhecendo tanto o paciente quanto a família como os profissionais da área. Assim, o anteprojeto propõe ambientes internos e externos que promovam segurança, pertencimento e suporte emocional, transformando o centro oncológico em uma infraestrutura de apoio à vida e à dignidade humana.

Dessa forma, o anteprojeto busca demonstrar como a arquitetura pode atuar além da função técnica, tornando-se parte ativa do processo de cuidado e humanização no tratamento oncológico. A partir dos conceitos de permanência, sensibilidade e acolhimento, a proposta integra arquitetura e paisagismo na criação de ambientes mais humanos, terapêuticos e conectados às necessidades físicas e emocionais dos usuários. Assim, o Centro Oncológico Multidisciplinar com apoio à família pretende consolidar-se como um espaço de suporte, convivência e bem-estar, promovendo qualidade de vida e fortalecendo a relação entre paciente, família e ambiente construído.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

Esta síntese interpretativa busca construir uma fundamentação teórica baseada nos conceitos de permanência, sensibilidade e acolhimento, compreendendo a arquitetura e o paisagismo como elementos ativos no processo de cuidado oncológico. A proposta entende que o espaço físico ultrapassa sua função técnica, tornando-se parte da experiência terapêutica entre paciente e família.

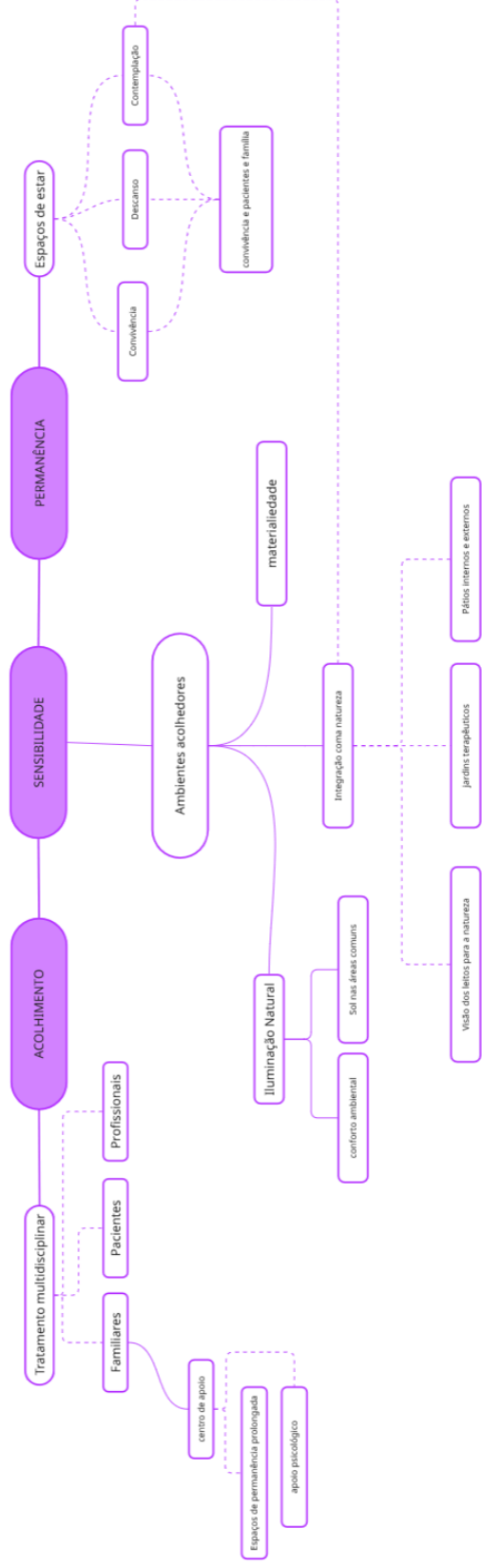
O conceito de acolhimento estrutura-se na necessidade de superar a lógica hospitalar tradicional, muitas vezes associada a ambientes hostis e impessoais. O câncer é compreendido como um processo de “adoecimento coletivo”, que impacta profundamente a dinâmica familiar e gera vulnerabilidades emocionais e psicossociais. Nesse contexto, o projeto reconhece a importância de espaços voltados não apenas ao paciente, mas também aos familiares, que frequentemente passam despercebidos pelo sistema de saúde. Assim, a proposta busca criar ambientes mais humanizados, utilizando iluminação natural, materialidade, escala humana e integração com áreas de convivência como estratégias para promover conforto, segurança e pertencimento aos usuários.

A sensibilidade do projeto manifesta-se na integração entre arquitetura, paisagismo e natureza como estratégias terapêuticas. Fundamentado nos estudos de Roger Ulrich, o anteprojeto utiliza os princípios do *Evidence-Based Design*, que comprovam a influência positiva da iluminação natural, das áreas verdes e dos jardins terapêuticos na redução do estresse e na recuperação dos pacientes (ULRICH, 1984). Dessa forma, o paisagismo deixa de possuir apenas caráter contemplativo e passa a atuar como ferramenta restauradora, estimulando bem-estar físico e emocional por meio da conexão com a natureza.

O conceito de permanência relaciona-se à necessidade de criar ambientes confortáveis e qualificados para usuários que permanecem longos períodos em tratamento ambulatorial. Para isso, a proposta adota os princípios de João Filgueiras Lima (Lelé), que defendia uma arquitetura hospitalar integrada ao conforto ambiental, à funcionalidade e à humanização dos espaços. A utilização de estratégias passivas, como ventilação e iluminação natural, além da relação entre ambientes internos e externos, busca promover qualidade espacial e bem-estar aos usuários.

Dessa forma, a integração entre acolhimento, sensibilidade e permanência permite estruturar um novo olhar para a arquitetura hospitalar contemporânea. Ao unir a humanização dos espaços, a relação terapêutica com a natureza e a qualidade ambiental, o Centro Oncológico Multidisciplinar propõe uma infraestrutura de suporte à vida, capaz de oferecer conforto e apoio emocional durante todo o processo de tratamento.

DIAGRAMA CONCEITUAL



REFERÊNCIAS

CARVALHO, Célia da Silva Ulysses de. **A Necessária Atenção à Família do Paciente Oncológico**. Revista Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 53, n. 1, p. 97-102, 2007.

DE BORTOLI, Cleunir de Fátima Candido et al. **Sentimentos de familiares de pacientes oncológicos atendidos em casas de apoio: revisão integrativa**. Pato Branco: Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, 2020.

FARIAS, Amanda Xavier; MARTINS, Termia Teixeira Pereira; COUTO, Giullia Bianca Ferracioli de. **A importância da equipe multidisciplinar no tratamento do paciente oncológico**. [S.l.]: Faculdade Guaraf-FAG, 2024.

TANAKA, Hugo; MEDEIROS, Gabriela; GIGLIO, Auro. **Multidisciplinary teams: perceptions of professionals and oncological patients**. Revista da Associação Médica Brasileira, [S.l.], v. 66, n. 4, p. 419-424, 2020.

ULRICH, Roger S. **View through a window may influence recovery from surgery**. Science, [S.l.], v. 224, n. 4647, p. 420-421, 27 abr. 1984.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). **INCA estima 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil entre 2026 e 2028**. Rio de Janeiro: INCA, 4 fev. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/noticias/2026/inca-estima-781-mil-novos-casos-de-cancer-por-ano-no-brasil-entre-2026-e-2028>. Acesso em: 11 maio 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). **Região Sul - estimativa dos casos novos**. Rio de Janeiro: INCA, 8 set. 2022 (atualizado em 4 fev. 2026). Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros-de-cancer/estimativa-por-regiao/regiao-sul-estimativa-dos-casos-novos>.

GUERRA, Abilio; MARQUES, André. **João Filgueiras Lima, ecologia e racionalização**. Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 181.03, Vitruvius, jun. 2015. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.181/5592>.

MERIN, Gili. **Peter Zumthor: Seven Personal Observations on Presence In Architecture**. ArchDaily, 3 dez. 2013. Disponível em: <https://www.archdaily.com/452513/peter-zumthor-seven-personal-observations-on-presence-in-architecture>.

SIMÃO, Fernanda Cristina dos Santos. **Custo do câncer no SUS**. Observatório de Oncologia, 2 maio 2024. Disponível em: <https://observatoriodeoncologia.com.br/custo-do-cancer-no-sus/>.